

 	Hôpital Bicêtre	Procédure
	CHOLECYSTECTOMIE COELIO	Réf : smq-reference Version : 1 Date d'application : smq-dateapplication Date de fin de validité : smq-limval Page 1 sur 5

	NOM, FONCTION	DATE
RÉDACTION		Date de rédaction
VALIDATION		Date de validation
APPROBATION	SMQ-APPROBATEURS	Date d'approbation

Groupe de travail :

Principales modifications par rapport à la version précédente : smq-objet-modif

1. OBJET

Cette fiche décrit la procédure et le matériel nécessaire lors d'une cholécystectomie.

2. DOMAINE D'APPLICATION

Cette procédure s'applique au bloc opératoire commun du CHU de Bicêtre.

3. RESPONSABILITÉS/ PERSONNES CONCERNÉES

IBODE, IDE, EBODE, chirurgiens, internes en chirurgie, externes.

4. DESCRIPTION

Définition :

La **cholécystectomie en coelioscopie** est une **intervention chirurgicale mini-invasive** consistant à réaliser l'**ablation complète de la vésicule biliaire** par **voie laparoscopique**.

But :

- Traiter la **lithiase vésiculaire symptomatique**
- Prévenir les complications biliaires (cholécystite aiguë, pancréatite aiguë biliaire, angiocholite)
- Supprimer le **réservoir lithiasique** de façon définitive

Principe :

- Installation en **décubitus dorsal**
- Open coelio et mise en place trocart de 11
- Création d'un **pneumopéritoine**
- Mise en place des **2 à 3 trocars de 5**
- Dissection du **triangle de Calot**
- Identification du **canal cystique** et de l'**artère cystique**
- Obtention de la **Critical View of Safety**
- Section et ligature du canal et de l'artère cystiques
- Décollement de la vésicule du lit hépatique et **extraction en endobag**

Fin de l'intervention

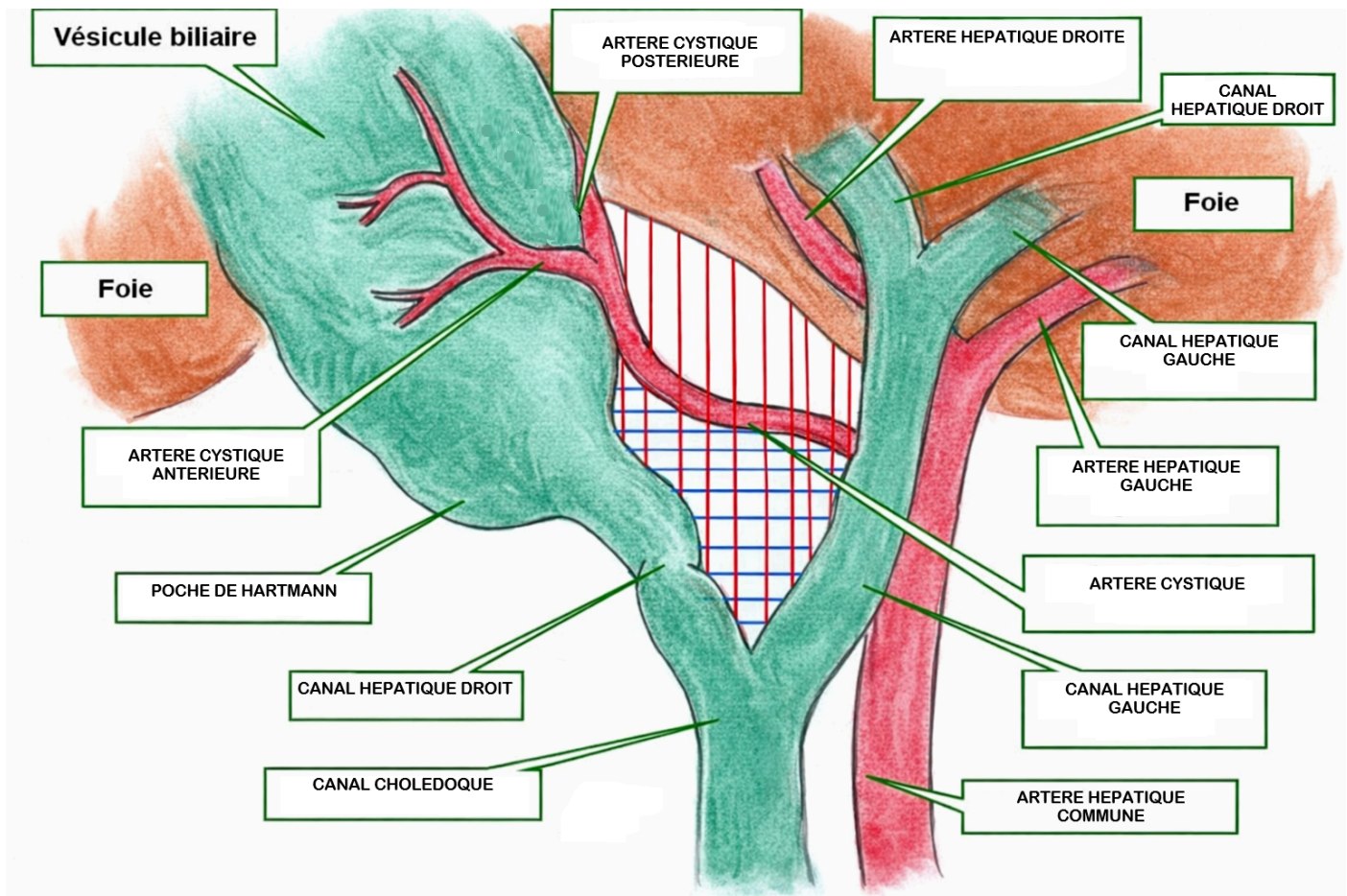
- Section et ligature du canal cystique et de l'artère cystique
- Ablation de la vésicule biliaire
- Extraction dans un sac endoscopique
- Contrôle de l'hémostase

Intérêts de cette stratégie combinée

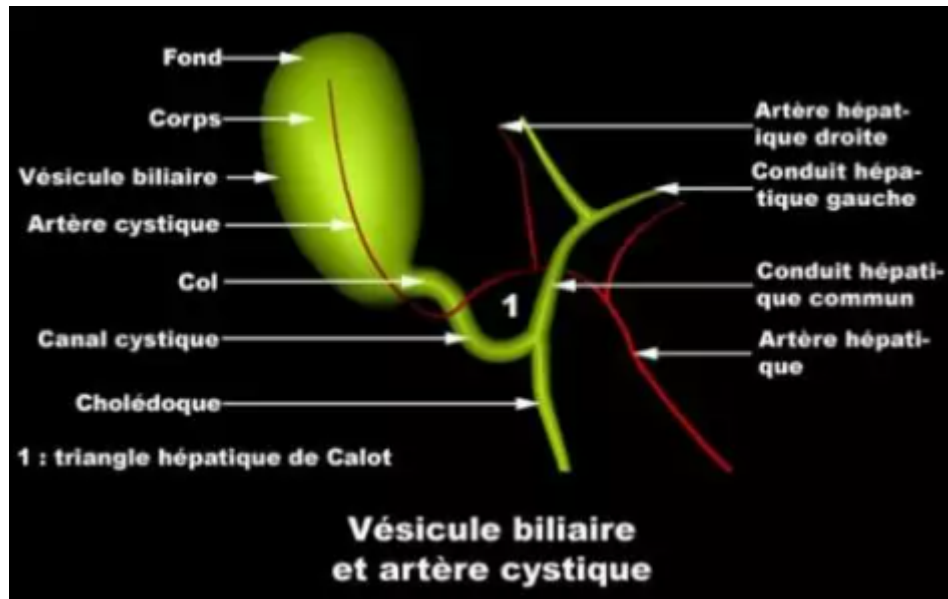
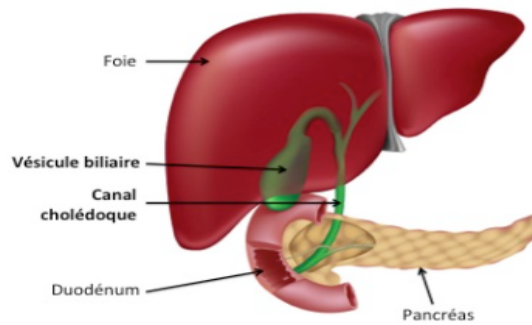
- Sécurisation du geste chirurgical
- Diminution du risque de plaie de la voie biliaire principale
- Traitement complet de la pathologie biliaire en un temps ou de façon séquentielle
- Bénéfice de la chirurgie mini-invasive



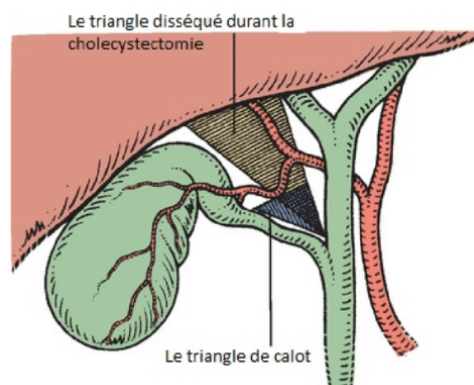
TRIANGLE DE CALOT



Le foie, la vésicule biliaire, le pancréas



Critical View of Safety



Installation :

Patient installé en décubitus dorsal, avec jambières, bras droit ou gauche le long du corps selon l'opérateur, colonne vidéo positionnée en haut à droite.

Matériel :

Mobile : 2 grandes tables, 1 petite table

Techniques : Colonne vidéo, GHF.

Installation : Table opératoire, Jambières, Gélouses

DMRS

Boite Coelio
Optique 0° ou 30°

Consommables : DM & DMS

Pack coelioscopie	Casaques	Electrode neutre	Plateau badigeon
Tubulure d'insufflation	Poignée de scialytique	Housse caméra	Trocarts Ø 5
Champ abdominaux	Poche à instruments coelio	Compressees RX	Trocarts Ø 10
Aspiration coelio Ø 5	Sac de recueil endoscopie type GR1	Compressees NT	Lame 11
Clips Hem-o-lock	Pot d'anapath	Cupule	

Fil de base :

Pharmacie :

Bétadine jaune

Bétadine rouge

Sérum physiologique

Examen :

Anatomo-pathologie



Prévoir le matériel pour la conversion (cf fiche)